

El Día Internacional de Acción contra la Migraña visibiliza su vínculo con la salud mental, Papeles del Psicólogo publica dos revisiones sobre neuropsicología de la violencia de género y del deterioro cognitivo subjetivo: claves del 12 de septiembre de 2026



SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

El 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña, que este año pone el foco en el lenguaje utilizado para hablar de esta enfermedad y en su relación bidireccional con la ansiedad y la depresión. El tercer número de 2026 de la revista Papeles del Psicólogo, editada por el Consejo General de la Psicología, publica una revisión sistemática sobre las alteraciones neuropsicológicas en mujeres víctimas de violencia de género y una revisión teórica sobre el deterioro cognitivo subjetivo como posible marcador preclínico de demencia. Ambos trabajos refuerzan el papel de la evaluación neuropsicológica en la práctica clínica.

Noticias nacionales

CLÍNICA · NACIONAL

Día Internacional de Acción contra la Migraña: el lenguaje importa y la Psicología tiene un papel clave en su abordaje

Cada 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña, un trastorno primario caracterizado por ataques recurrentes de entre 4 y 72 horas que pueden cursar con dolor pulsátil, sensibilidad a la luz y al sonido, náuseas y vómitos. En 2026, la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) pone el foco en el lema #LasPalabrasImportan, en línea con la Guía de estilo de migraña elaborada por el Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y avalada por AEMICE. Esta guía recomienda hablar de "migraña" en singular y de "persona con migraña", evitando términos como "migrañoso" o reducir la enfermedad a un simple dolor de cabeza. Según datos de la OMS recogidos en el artículo, las cefaleas afectaron en 2021 aproximadamente al 40% de la población mundial, y la migraña ocupó el tercer lugar entre las enfermedades neurológicas con mayor carga de discapacidad. En España, la enfermedad afecta a más de 6 millones de personas, alrededor del 13% de la población, con mayor prevalencia entre mujeres. El artículo, publicado en Infocop, subraya que la relación entre migraña y salud mental es bidireccional: la ansiedad y la depresión son más frecuentes entre quienes padecen migraña, y estos problemas pueden a su vez favorecer una evolución más desfavorable de la enfermedad, en parte por mecanismos genéticos, neurobiológicos, hormonales y ambientales compartidos. Según la American Migraine Foundation, los problemas de salud mental afectan aproximadamente al 54% de las personas con más de 15 días de migraña al mes, frente al 34% de quienes tienen menos de 15. Entre las intervenciones psicológicas con mayor respaldo empírico se encuentran la terapia cognitivo-conductual, las técnicas de relajación y el biofeedback, mientras que las intervenciones basadas en mindfulness y la Terapia de Aceptación y Compromiso cuentan con una base empírica específica todavía menor para esta enfermedad. La intervención psicológica no implica considerar que la migraña tenga un origen psicológico, sino abordar los procesos emocionales, cognitivos y conductuales que pueden modular la experiencia del dolor y la discapacidad asociada.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Una revisión sistemática documenta alteraciones neuropsicológicas en mujeres víctimas de violencia de género

La revista *Papeles del Psicólogo*, editada por el Consejo General de la Psicología de España, ha publicado en su tercer número de 2026 (volumen 47, número 3, páginas 181 a 188) una revisión sistemática firmada por Carolina Vivas Trussi y Almudena Iniesta Martínez, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, titulada "Alteraciones neuropsicológicas en mujeres víctimas de violencia de género". El trabajo, elaborado siguiendo la metodología PRISMA, seleccionó 10 estudios de bases de datos como EBSCO, ResearchGate y ScienceDirect, tras identificar inicialmente 164 resultados. La revisión señala que la violencia de género afecta a 1 de cada 3 mujeres según la OMS, y que la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 (Ministerio de Igualdad), con una muestra de 9.568 mujeres, encontró que el 50,2% había sufrido violencia psicológica, el 11% violencia física, el 8,9% violencia sexual y el 11,5% violencia económica. Los 10 estudios analizados, realizados entre 2002 y 2022 en países como España, EE. UU., Francia, Taiwán, Polonia y Guatemala, coinciden en mostrar que las mujeres víctimas de violencia de género presentan un rendimiento inferior en pruebas neuropsicológicas de atención sostenida y alternante, memoria de trabajo, memoria visual y memoria autobiográfica, así como en funciones ejecutivas como la inhibición de respuesta, la planificación y el razonamiento. Uno de los estudios incluidos, realizado en España, encontró que alrededor del 25% de las mujeres que sufren violencia presentan deterioro neuropsicológico leve y un 5% deterioro severo, principalmente en atención, memoria y funciones ejecutivas. Como posibles mecanismos explicativos, la revisión apunta al daño cerebral directo por golpes en la cabeza, al daño indirecto derivado de las secuelas del estrés postraumático y a la alteración en la secreción de cortisol observada en mujeres maltratadas. Las autoras señalan limitaciones como el reducido número de estudios disponibles, la diversidad de modelos teóricos sobre funciones ejecutivas y el carácter transversal de la mayoría de los diseños, que impide establecer relaciones de causa-efecto. Entre las implicaciones prácticas, subrayan la necesidad de incorporar la evaluación y rehabilitación neuropsicológica en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, así como su relevancia en procesos forenses, donde

actualmente estos déficits no suelen considerarse para establecer la imputabilidad o las compensaciones económicas a la víctima.

Fuente: Papeles del Psicólogo / Psychologist Papers (Consejo General de la Psicología de España)

NEUROCIENCIA · NACIONAL

El deterioro cognitivo subjetivo se perfila como posible marcador temprano de riesgo de demencia, según una revisión teórica

En el mismo tercer número de 2026 de Papeles del Psicólogo (volumen 47, número 3, páginas 223 a 231), un equipo de la Universidad de Valencia, la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de Zaragoza y la Red Española de Investigación en Salud Mental (CIBERSAM), formado por Vanesa Pérez, Daniela Batallas, Vanesa Hidalgo y Alicia Salvador, ha publicado una revisión teórica titulada "Deterioro cognitivo subjetivo como marcador preclínico de demencia", centrada exclusivamente en estudios longitudinales en adultos mayores. El deterioro cognitivo subjetivo (DCS) se define como la percepción persistente de un declive cognitivo, particularmente de la memoria, en ausencia de déficits objetivos en pruebas estandarizadas. Según recuerda el artículo, la OMS estima que más de 55 millones de personas viven actualmente con demencia en el mundo, una cifra que podría triplicarse para 2050. Entre los hallazgos revisados, un estudio con 873 personas encontró que un incremento anual de un punto en la intensidad del DCS se asoció con un riesgo casi cuatro veces mayor de desarrollar demencia en un plazo de diez años, y otro con 3.585 adultos mayores halló que el DCS antecedió en promedio al deterioro cognitivo leve por 4,4 años y a la demencia por 6,9 años. La revisión también identifica factores que modulan este riesgo, como los antecedentes familiares de demencia, la persistencia de las quejas cognitivas en el tiempo, el sexo femenino, la presencia del alelo APOE ε4, la sintomatología depresiva o ansiosa y determinados rasgos de personalidad. Un estudio con 14.066 personas mayores de 50 años encontró que la coexistencia de ansiedad y DCS elevaba al 25% la probabilidad de progresar a deterioro cognitivo leve o demencia en una media de 3,1 años, frente a los 8,2 años en quienes no presentaban ninguno de los dos factores. A partir de la evidencia revisada, las autoras proponen un modelo preliminar de evaluación integral en cinco fases para la práctica profesional: evaluación estandarizada de la queja cognitiva mediante

cuestionarios validados como el SCD-Q, validación externa con un informante fiable, evaluación neuropsicológica sensible a cambios sutiles, valoración de factores emocionales y psicosociales, e integración de biomarcadores cuando los recursos lo permitan. El estudio ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Red Española de Investigación sobre el Estrés y la Generalitat Valenciana.

Fuente: Papeles del Psicólogo / Psychologist Papers (Consejo General de la Psicología de España)

Publicaciones científicas recientes

Vivas Trussi, C., e Iniesta Martínez, A. (2026). Alteraciones neuropsicológicas en mujeres víctimas de violencia de género: una revisión sistemática. *Papeles del Psicólogo/ Psychologist Papers*, 47(3), 181-188.

DOI: [10.70478/pap.psicol.2026.47.20](https://doi.org/10.70478/pap.psicol.2026.47.20)

Hallazgo: Revisión sistemática con metodología PRISMA que analizó 10 estudios de cohortes y correlacionales (2002-2022, con muestras de entre 28 y 108 mujeres) sobre el funcionamiento neuropsicológico de mujeres víctimas de violencia de género. Los estudios, de forma consistente, encontraron un rendimiento inferior de las víctimas frente a grupos control en pruebas de atención, memoria de trabajo, memoria visual y autobiográfica, y funciones ejecutivas (inhibición, planificación, razonamiento y flexibilidad cognitiva), con una gravedad del deterioro que varió de leve a severo según el estudio.

Implicación clínica: Los resultados sugieren que la evaluación y rehabilitación neuropsicológica podrían ser componentes relevantes de una atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, y podrían orientar también la consideración de estas secuelas en procesos forenses, donde actualmente no suelen evaluarse de forma sistemática.

Pérez, V., Batallas, D., Hidalgo, V., y Salvador, A. (2026). Deterioro cognitivo subjetivo como marcador preclínico de demencia: una revisión teórica y marco conceptual de estudios longitudinales en adultos mayores. *Papeles del Psicólogo/ Psychologist Papers*, 47(3), 223-231.

DOI: [10.70478/pap.psicol.2026.47.24](https://doi.org/10.70478/pap.psicol.2026.47.24)

Hallazgo: Revisión teórica de estudios longitudinales que analiza la relación entre el deterioro cognitivo subjetivo (DCS) y la progresión hacia deterioro cognitivo leve o demencia, incorporando factores neuropsicológicos, sociodemográficos, psicosociales y biomarcadores (amiloide, APOE ϵ 4, neuroimagen). Los estudios revisados muestran de forma consistente que el DCS persistente se asocia con mayor riesgo de progresión clínica, con diferencias según sexo, etnia y presencia de comorbilidades emocionales como ansiedad y depresión.

Implicación clínica: Los resultados pueden orientar el desarrollo de protocolos de evaluación integral del DCS en la práctica profesional, combinando cuestionarios estandarizados, validación por informante, evaluación neuropsicológica sensible y valoración de factores emocionales, con el objetivo de mejorar la detección temprana de personas con mayor riesgo de progresión hacia deterioro cognitivo leve o demencia.

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Cuestionarios estandarizados de queja cognitiva subjetiva:** Instrumentos psicométricos validados, como cuestionarios de declive cognitivo percibido y de fallos de memoria en la vida cotidiana, que permiten cuantificar la percepción de deterioro cognitivo del paciente y de un informante cercano mediante puntos de corte normativos, en lugar de basarse únicamente en preguntas abiertas sobre la memoria.

Prioridades del día

Cuidar el lenguaje al hablar de migraña con pacientes y en redes

Puede ser útil revisar el lenguaje utilizado al hablar de la migraña, evitando reducirla a "un dolor de cabeza" o etiquetar a la persona como "migrañosa", y optando por expresiones centradas en la persona, en línea con las

recomendaciones de la guía de estilo elaborada por la Sociedad Española de Neurología.

Explorar la evaluación neuropsicológica en el abordaje de la violencia de género

Puede ser relevante incorporar, cuando el caso lo permita, una valoración de posibles dificultades atencionales, mnésicas o ejecutivas en mujeres víctimas de violencia de género, dado que estas secuelas pueden pasar desapercibidas y no suelen contemplarse de forma sistemática en la atención habitual.

Prestar atención a las quejas cognitivas persistentes en personas mayores

Puede ser oportuno explorar de forma estructurada las quejas subjetivas de memoria en personas mayores, especialmente cuando son persistentes en el tiempo o están validadas por un informante cercano, ya que la evidencia longitudinal las señala como un posible indicador temprano de riesgo que puede beneficiarse de seguimiento.